

العضلة العاصرة البولية الاصطناعية (AUS) جهاز صغير يُزرع تحت الجلد تمامًا، يعيد التحكم في المثانة عند سلس البول — وغالبًا بعد جراحة البروستاتا. تتحكم فيه بنفسك عبر مضخة مخفية في كيس الصفن. يشرح هذا الملف كيف يعمل الجهاز وكيف تستعد وما الذي نتوقعه.

عن هذا الإجراء

تسرّب البول عند النشاط أو السعال أو الرفع يُسمى **سلس البول الإجهادي (SUI)**، وكثيرًا ما يعقب جراحة البروستاتا. يعالجه AUS بثلاثة أجزاء مترابطة كلها تحت الجلد:

- كفة ناعمة تلتفّ حول الإحليل (مجرى البول) وتضغطه برفق للحفاظ على الجفاف
- مضخة في كيس الصفن تضغطها عند الرغبة في التبول
- بالون صغير في أسفل البطن يضبط الضغط

طريقة الاستخدام: عادةً تبقى الكفة مغلقة فتحافظ على جفافك. عند الحاجة للتبول، اضغط المضخة وأطلقها عدة مرات — تفتّح الكفة وتتبول. بعد دقائق تمتلئ الكفة وتغلق من تلقاء نفسها.

هل هو آمن؟

AUS هو العلاج المعياري الذهبي المعتمد منذ أمد طويل لهذا النوع من سلس البول، ويحقق معظم الرجال تحكمًا جيدًا. كأي زرعة، يحمل بعض المخاطر — أبرزها العدوى أو تآكل الجهاز أو الإحليل مع الوقت مما قد يستدعي إصلاحًا لاحقًا. يقلّل الفريق الطبي خطر العدوى بالمضادات الحيوية والتقنية المعقمة وعلاج أي عدوى بولية مسبقًا.

تعلم المصطلحات

سلس البول الإجهادي

تسرّب البول عند النشاط أو السعال أو الرفع.

الإحليل

الأنبوب الذي يحمل البول خارج الجسم.

الكفة

الجزء الذي يضغط الإحليل برفق ليحافظ على الجفاف.

المضخة

الجزء الموجود في كيس الصفن تضغطه لفتح الكفة والتبول.

التفعيل

تشغيل الجهاز في زيارة بعد نحو 6 أسابيع من الجراحة عند اكتمال الشفاء.

إلغاء التفعيل

إيقاف الجهاز (إبقاء الكفة مفتوحة) — ضروري قبل أي قسطرة.

التخدير العام

دواء يُقيئك نائمًا وخاليا من الألم أثناء الجراحة.

تنظير المثانة

فحص بالكاميرا للإحليل والمثانة، يُجرى في الغالب قبل الجراحة.

هل سيؤلم؟ تُجرى الجراحة تحت التخدير العام أو النصفى فلا تشعر بشيء خلالها. بعدها تَوقَّع ألماً وتورماً وكدمات في كيس الصفن والمنطقة بين الصفن والشرج لأسبوعين — يساعد ارتداء دغامة الصفن والتلج ومسكنات الألم. تستغرق الجراحة نحو 1-2 ساعة، ويعود كثير من المرضى للمنزل في اليوم ذاته.

كيف تستعدّ (قبل الجراحة)

- تُجرى تحت التخدير العام أو النصفى — اتَّبِع جميع تعليمات الجراحة (الصيام وإيقاف الأدوية بما فيها مميعات الدم).
- تحليل البول يكشف العدوى — يجب علاج أي عدوى أولاً، لذا قد تُؤَجَّل الجراحة إن وُجدت.
- لا تدخّن ولا تستخدم السجائر الإلكترونية؛ اغتسل بالصابون المطهّر المقدم وتناول المضادات الحيوية حسب التوجيهات — الوقاية من العدوى أولوية لأن الجهاز يُزرع داخل الجسم.

أخبر فريقك الطبي مسبقاً إذا:

- تلقّيت إشعاعاً على الحوض، أو أُجريت لك جراحة في الإحليل أو سلس البول من قبل
- كنت مصاباً بالسكري أو تجد صعوبة في استخدام يديك (أنت من يشغل المضخة)
- كان لديك أي عدوى في أي مكان

ما الذي يحدث أثناء الجراحة

- 1 تكون نائماً أو مخدّراً من الخصر للأسفل، وتُعطى المضادات الحيوية.
- 2 من خلال شقوق صغيرة، يضع الجراح الكفة حول الإحليل، والبالون في أسفل البطن، والمضخة في كيس الصفن — جميعها تحت الجلد.
- 3 يُملأ الجهاز ويُختبر ثم يُترك مغلقاً حتى يكتمل التعافي.

بعد الجراحة

- تَوقَّع تورماً وكدمات في الصفن والعجان لمدة 1-2 أسبوع. ارتدِ دغامة الصفن، واستخدم الثلج، وتجنّب الرفع الثقيل والجهد وركوب الدراجة والجنس وفق توجيهات جراحك.
- يبقى الجهاز مغلقاً نحو 6 أسابيع. ستستمر في التسريب واستخدام الحفاضات — هذا طبيعي. لا تضغط المضخة حتى يشغلها جراحك.
- في زيارة بعد نحو 6 أسابيع، يشغل جراحك الجهاز ويعلمك كيفية استخدام المضخة.
- أخبر دائماً أي طبيب أو ممرض أن لديك AUS — يجب إيقافه قبل أي قسرة وإلا قد يتضرر الإحليل. احمِل بطاقة تنبيه طبي.

اتصل بفريقك الطبي إذا كان لديك:

- حمى أو قشعريرة أو احمرار أو ألم أو إفراز متزايد عند موضع الشق
- عجز مفاجئ تام عن التبول
- تورم شديد أو تصلب أو ألم متصاعد في كيس الصفن

ثلاثة أمور تذكّرها

1. AUS جهاز مخفي يعيد التحكم في المثانة — الكفة تحافظ على الجفاف وتضغط المضخة في الصفن للتبول.
2. يبقى مغلقاً نحو 6 أسابيع (ستستمر في التسريب — هذا طبيعي)، ثم يشغل ويُعلمك استخدامه.
3. الوقاية من العدوى أهم شيء: عالِج أي عدوى أولاً، لا تدخّن، استخدم الغسل والمضادات الحيوية. أخبر دائماً أي مقدم رعاية أن لديك AUS — يجب إيقافه قبل أي قسرة.